

Praca i ujawnianie

Czy mówić w pracy o ChAD? Komu, kiedy, jak? Ten handout przedstawia ramy decyzji bez gotowej odpowiedzi — bo właściwa odpowiedź zależy od Twojej sytuacji, branży, kultury miejsca pracy.

CZAS: 45 min · refleksja **Decyzja indywidualna** **ŹRÓDŁO:** Michalak i wsp. (2007); Hampson i wsp. (2015)

JAK UŻYWAĆ

Decyzja o ujawnieniu diagnozy w pracy jest **indywidualna i odwracalna w jednym kierunku** — raz ujawnione, nie da się cofnąć. Ten handout daje cztery kategorie do rozważenia: **kto** (kierownik, dział kadr, lekarz medycyny pracy, koledzy), **kiedy** (przed rekrutacją, na początku, w kryzysie, nigdy), **jak** (pełna diagnoza, ogólnie „problemy zdrowotne”, przez lekarza), **co dokładnie** (jakie objawy, jakie potrzeby). Nie ma jednej dobrej odpowiedzi — zależy od branży, kultury, sytuacji, etapu kariery, jakości relacji w pracy.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Michalak i wsp. (2007) w badaniu jakościowym 100 osób z ChAD wykazali, że **ujawnienie diagnozy w pracy** wiąże się z dużą zmiennością konsekwencji: **33%** osób raportowało pozytywne skutki (więcej wsparcia, lepsze relacje, możliwość dostosowań), **33%** neutralne, **34%** negatywne (stygmatyzacja, blokada awansu, w ekstremalnych przypadkach utrata pracy). Czynniki rozróżniające: **kultura firmy**, jakość relacji z kierownikiem, branża (lepiej w sektorze zdrowia i edukacji niż w finansach i wojsku), zaawansowanie kariery (lepiej po ustabilizowaniu pozycji). Konsekwencja praktyczna: **nie ma jednej rekomendacji** — ale jest seria pytań, które warto sobie zadać przed decyzją.

01 ? Cztery pytania do siebie przed decyzją

1 · PO CO UJAWNIAM?

Konkretna potrzeba (np. *dostosowanie godzin pracy*, możliwość wzięcia urlopu zdrowotnego, ograniczenie podróży)? Czy potrzeba autentyczności i odciążenia? Pierwsze często wymaga ujawnienia; drugie często nie.

2 · KTO JEST ODBIORCĄ?

Bezpośredni kierownik (najczęściej największy wpływ) · dział kadr (formalne dostosowania) · lekarz medycyny pracy (drogi formalne) · kolega z zespołu (codzienna obecność). Każdy odbiorca = inne konsekwencje.

3 · JAKA JEST KULTURA MIEJSCA PRACY?

Czy ktoś z firmy mówił otwarcie o swoim zdrowiu psychicznym? Czy firma ma programy zdrowia psychicznego? Czy w komunikacji wewnętrznej pojawiają się tematy zdrowia? Brak wszystkich = ostrożność.

4 · JAKI ETAP KARIERY?

Stała umowa po latach pracy = znacznie bezpieczniej niż umowa próbna. Awans na zaufanej pozycji = łatwiej. *Świeżo zatrudniony/-a* — *pomyśl dwa razy*, chyba że ujawnienie jest konieczne.

02 🌱 Trzy strategie ujawniania — gradient

A · PEŁNE

„Mam chorobę afektywną dwubiegunową — leczę się, biorę leki, mam epizody średnio raz na 2 lata.” Pełna diagnoza i konsekwencje. **Dobre gdy:** kultura otwarta, długa relacja z kierownikiem.

B · FUNKCJONALNE

„Mam przewlekły stan zdrowia, który czasem wymaga elastyczności godzin lub krótkich nieobecności. Leczę się, jest pod kontrolą.” **Diagnoza nieujawniona, potrzeby tak.** Najczęściej wystarczające.

C · BEZ UJAWNIANIA

Decyzja, by *nie* mówić nikomu w pracy. Wsparcie zewnętrzne (terapeuta, bliscy). **Dobre gdy:** branża niesprzyjająca, świeże zatrudnienie, dobre samopoczucie funkcjonalne.

03 Prawa pracownika w Polsce — ramy

Diagnoza psychiatryczna jest informacją wrażliwą (art. 9 RODO) — nie masz obowiązku jej ujawniać pracodawcy. **Lekarz medycyny pracy** wydaje orzeczenie o *zdolności do pracy*, nie ujawnia diagnozy.

Zwolnienie lekarskie: psychiatra może wystawić L4. Pracodawca widzi tylko fakt zwolnienia, nie diagnozę.

Orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli wnioskujesz): daje dodatkowe prawa pracownicze — krótszy czas pracy, dodatkowe dni wolne, ochrona przed zwolnieniem. Diagnoza znana lekarzowi orzecznikowi, nie pracodawcy. Stopień zwykle lekki/umiarkowany.

Dyskryminacja: Kodeks pracy (art. 11³, 18^{3a}) zakazuje dyskryminacji ze względu na stan zdrowia. Państwowa Inspekcja Pracy i sądy pracy w razie naruszenia.

Te informacje to ogólne ramy — przed decyzją finansową/prawną skonsultuj z prawnikiem.

04 Konkretnie dostosowania — o co warto poprosić

- ☐ Elastyczne godziny pracy (start 9:00 zamiast 7:00)
- ☐ Praca zdalna 2–3 dni w tygodniu
- ☐ Ograniczenie pracy zmianowej i nocnej
- ☐ Ograniczenie podróży międzykontynentalnych

- ☐ Możliwość wyjścia na sesję terapeutyczną w tygodniu
- ☐ Stała pora kończenia pracy (bez nadgodzin)
- ☐ Stopniowy powrót po dłuższej nieobecności
- ☐ Stała osoba kontaktowa do informowania o sytuacji

Klucz: Hampson i wsp. (2015) w 5-letnim badaniu pokazali, że *najsilniejszym pojedynczym predyktorem* utrzymania zatrudnienia u osób z ChAD nie była ciężkość choroby ani ujawnienie diagnozy — lecz **jakość relacji z bezpośrednim kierownikiem**. Jedna otwarta, dobra relacja z osobą decyzyjną może znaczyć więcej niż formalny status diagnostyczny. Inwestuj w tę relację w *eutymii*, zanim będziesz potrzebował/-a pomocy. W kryzysie szukasz nie życzliwości obcej osoby, ale wsparcia kogoś, kto już Cię zna i ceni.